

TEMA 10.16 • REUMATOLOGÍA

Otras Miopatías

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las miopatías autoinmunes y los síndromes dolorosos musculares representan un desafío diagnóstico frecuente. Más allá de la **Polimiositis** y la **Dermatomiositis**, existen dos entidades fundamentales que el médico general debe saber diferenciar por su manejo y pronóstico radicalmente distintos: la **Miositis por Cuerpos de Inclusión (MCI)** y la **Polimialgia Reumática (PMR)**.

Miositis por Cuerpos de Inclusión (MCI)

La Miositis por Cuerpos de Inclusión es una enfermedad inflamatoria crónica del músculo que, a diferencia de otras miopatías, combina procesos inflamatorios y degenerativos.

Epidemiología y Perfil del Paciente

Es característica de sujetos mayores, habitualmente **por encima de los 70 años**. Aunque la **Polimiositis** también puede verse en adultos mayores, la MCI es la miopatía inflamatoria más frecuente en pacientes de este grupo etario.

Clínica y Distribución de la Debilidad

Presenta una debilidad muscular de tipo proximal, pero con un patrón de distribución muy específico que permite sospecharla: - **Cuádriceps**: Es común la atrofia y debilidad temprana de este grupo muscular, lo que provoca caídas frecuentes. - **Antebrazos**: Existe una afectación característica de los flexores de la muñeca y los dedos. La debilidad es más marcada en los **antebrazos** que en los brazos (bíceps/tríceps). - **Asimetría**: A diferencia de la polimiositis, la debilidad en la MCI puede ser asimétrica.

NOTA CLÍNICA

La debilidad en la MCI evoluciona de forma muy lenta y progresiva, lo que a menudo retrasa el diagnóstico ya que el paciente lo atribuye erróneamente al "envejecimiento normal".

Diagnóstico

1. **Laboratorio**: La Creatincinasa (**CK**) suele estar elevada, pero de forma leve a moderada. Generalmente, valores **menores a 1000 UI/L** orientan a MCI, mientras que valores muy elevados (>1000-5000) son más típicos de la **Polimiositis**. 2. **Biopsia Muscular (Gold Standard)**: Es la única forma de confirmar el diagnóstico. La biopsia revela fibras musculares con **vacuolas ribeteadas** y depósitos de proteínas (cuerpos de inclusión), además de infiltrado inflamatorio.

Tratamiento y Pronóstico

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La Miositis por Cuerpos de Inclusión **NO responde a los corticoides** ni a la mayoría de los inmunosupresores convencionales.

Actualmente, no existe un tratamiento farmacológico con eficacia demostrada para detener la enfermedad. El manejo se centra en terapia física y apoyo funcional. Su identificación es crucial para evitar la toxicidad innecesaria de tratamientos esteroidales a largo plazo en un paciente que no se beneficiará de ellos.

Polimialgia Reumática (PMR)

La Polimialgia Reumática es un síndrome clínico inflamatorio que afecta predominantemente a las estructuras periarticulares (bolsas y tendones) más que al músculo en sí.

Epidemiología y Asociación Clínica

- Se presenta casi exclusivamente en pacientes **mayores de 55-60 años**. - **Asociación con Vasculitis**: Existe una relación estrecha con la **Arteritis de la Temporal** (o Arteritis de Células Gigantes).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente con sospecha de PMR, siempre se debe realizar una anamnesis dirigida buscando síntomas de **Arteritis de la Temporal**: - Claudicación mandibular (dolor al masticar). - Amaurosis fugax (pérdida transitoria de la visión). - Dolor o hipersensibilidad en el cuero cabelludo (dolor al peinarse). - Cefalea de inicio reciente.

Cuadro Clínico: ¿Dolor o Debilidad?

La gran diferencia con las miopatías inflamatorias es la naturaleza del síntoma: - **Mialgia Proximal**: El paciente refiere dolor intenso en la cintura escapular (hombros) y cintura pélvica (cadera). - **Rigidez Matinal**: Muy marcada, que mejora parcialmente con el movimiento a lo largo del día. - **Fuerza Conservada**: Esta es la clave del examen físico. Aunque el paciente sienta que "no tiene fuerza" debido al dolor, al realizar una evaluación objetiva y acuciosa, la **fuerza muscular está conservada**.

Diagnóstico

- **CK (Creatincinasa)**: Típicamente **normal**. Su elevación debería hacer dudar del diagnóstico de PMR. - **VHS (Velocidad de Sedimentación)**: Se encuentra **muy elevada**, frecuentemente por encima de **80 o 100 mm/h**. Es un marcador de inflamación sistémica esencial para el diagnóstico.

Tratamiento

La respuesta al tratamiento es diagnóstica por su espectacularidad: 1. **Corticoides a dosis bajas**: Prednisona 10-20 mg/día vía oral. 2. **Respuesta dramática**: Los síntomas suelen desaparecer o mejorar significativamente en 24-48 horas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el paciente con PMR presenta síntomas de Arteritis de la Temporal, el tratamiento requiere dosis de **Corticoides mucho más altas** (habitualmente 1 mg/kg/día o pulsos de metilprednisolona si hay compromiso visual) para evitar la ceguera permanente.

Resumen Comparativo para EUNACOM

TABLA 10.16.1: CARACTERÍSTICA VS MIOSITIS POR CUERPOS DE INCLUSIÓN		
CARACTERÍSTICA	MIOSITIS POR CUERPOS DE INCLUSIÓN	POLIMIALGIA REUMÁTICA
Edad típica	> 70 años	> 55-60 años
Síntoma principal	Debilidad progresiva	Dolor y rigidez
Distribución	Cuádriceps y antebrazos	Cintura escapular y pélvica
Fuerza muscular	Disminuida (objetivo)	Conservada (objetivo)
CK	Elevada (leve, < 1000)	Normal
VHS	Normal o leve elevación	Muy elevada (> 80-100)
Biopsia	Cuerpos de inclusión	No requerida (clínica)
Respuesta a Corticoides	Nula / Pobre	Excelente (Dosis bajas)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te describen a un anciano que no puede levantarse de la silla por dolor y tiene una VHS de 100, la respuesta es **Polimialgia Reumática**. Si te describen a un anciano con caídas frecuentes, atrofia de cuádriceps y que no responde a prednisona, piensa en **Miositis por Cuerpos de Inclusión**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 75 años con debilidad progresiva en cuádriceps y antebrazos, CK levemente elevada y sin respuesta a corticoides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Otras Miopatías. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Miositis por cuerpos de inclusión: adulto mayor con debilidad en cuádriceps y antebrazos, CK levemente elevada, diagnóstico por biopsia, no responde a corticoides
- Polimialgia reumática: adulto mayor con mialgias proximales pero SIN debilidad muscular objetiva
- La polimialgia reumática se asocia a arteritis de células gigantes; buscar claudicación mandibular, amaurosis fugax y dolor del cuero cabelludo
- VHS muy elevada (80-100) es el marcador más orientador de polimialgia reumática
- CK >1000 orienta a polimiositis; CK levemente elevada orienta a miositis por cuerpos de inclusión
- Tratamiento de polimialgia reumática: prednisona oral en dosis baja (dosis alta si se asocia a arteritis temporal)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OTRAS MIOPATÍAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 75 años con debilidad progresiva en cuádriceps y antebrazos, CK levemente elevada y sin respuesta a corticoides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Polimiositis
- B)** Dermatomiositis
- C)** Miositis por cuerpos de inclusión
- D)** Polimialgia reumática
- E)** Miastenia gravis

PREGUNTA 2

Paciente de 68 años con mialgias proximales, rigidez matinal y VHS de 95 mm/h. Al examen físico las fuerzas están conservadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Polimiositis
- B)** Polimialgia reumática
- C)** Fibromialgia
- D)** Miositis por cuerpos de inclusión
- E)** Dermatomiositis

PREGUNTA 3

¿Qué patología debe buscarse dirigidamente en un paciente con polimialgia reumática?

- A)** Cáncer oculto
- B)** Lupus eritematoso sistémico
- C)** Arteritis de células gigantes
- D)** Esclerodermia
- E)** Síndrome antifosfolípido

RESUMEN: OTRAS MIOPATÍAS

Esta clase aborda dos miopatías que deben diferenciarse de la polimiositis y dermatomiositis: la miositis por cuerpos de inclusión y la polimialgia reumática. La miositis por cuerpos de inclusión se presenta en adultos mayores (>70 años) con debilidad muscular proximal pero con distribución característica en cuádriceps y antebrazos, a diferencia de la polimiositis donde predomina en hombros y cintura escapular. La CK suele estar solo levemente elevada (a diferencia de la polimiositis donde supera los 1000). El diagnóstico se confirma con biopsia muscular que muestra los cuerpos de inclusión, y no responde a corticoides. La polimialgia reumática se presenta también en adultos mayores (>55-60 años) con mialgias proximales y rigidez matinal, pero la diferencia fundamental es que no tiene debilidad muscular objetiva al examen físico. Se asocia fuertemente a arteritis de células gigantes, por lo que debe buscarse dirigidamente claudicación mandibular, amaurosis fugax y dolor del cuero cabelludo. La CK suele estar normal o mínimamente elevada, y la VHS está muy elevada (80-100). El tratamiento es con prednisona oral en dosis baja, salvo que se asocie a arteritis temporal donde se requieren dosis altas.